

SELARL LEXVOX AVOCATS · GUIDE VICTIME

PALIER 2 : LE KIT EXPERTISE

Kit Expertise accident

Préparez votre expertise médicale.

CONÇU ET RÉDIGÉ PAR

Maître Patrice Humbert

Avocat spécialiste CNB en dommage corporel · Barreau d'Aix-en-Provence

LEXVOX

ÉDITION 2026 · LEXVOX-VICTIME.COM

Dans ce guide

Kit Expertise accident : 4 documents.

1. Le guide de préparation de l'expertise médicale
2. La grille d'auto-recensement des 20 postes
3. Le tableau tierce personne
4. Le calculateur de pertes de gains

Le guide de préparation de l'expertise médicale

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre qui est vraiment le médecin qui vous examine, et si son rapport peut être discuté. - Préparer chaque réponse et chaque pièce pour que l'étendue réelle de vos séquelles soit constatée, sans rien minimiser ni exagérer. - Savoir quoi faire après l'examen, du rapport reçu aux observations et aux dires, pour ne pas laisser un constat incomplet devenir définitif.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Pourquoi cette journée décide de tout

L'expertise médicale est le moment le plus important de votre dossier. Tout part de là. Le rapport que le médecin va rédiger après vous avoir examiné servira de base au chiffrage de votre indemnisation. L'assureur y lira le montant qu'il propose. Le juge, s'il est saisi, s'y référera pour trancher. Une séquelle non signalée ce jour-là risque de ne jamais être réparée.

La plupart des victimes arrivent à cet examen sans préparation. Elles répondent de bonne foi, souvent en minimisant leurs douleurs par pudeur ou par courage. Elles oublient de mentionner la gêne qui a envahi leur quotidien. Elles quittent le cabinet du médecin en pensant que tout s'est bien passé. Le rapport, lui, ne retient que ce qui a été dit et montré.

Ce guide existe pour renverser ce rapport de force. Vous n'allez pas subir cet examen. Vous allez le préparer. Vous saurez qui vous fait face, ce que ce médecin cherche à établir, comment décrire votre vie réelle et quoi apporter.

Vous saurez aussi que le rapport n'est pas une sentence : il se relit, se conteste et se complète.

Il faut aussi nommer une réalité que beaucoup de victimes découvrent trop tard. L'expertise n'est pas un simple contrôle de vos blessures. C'est une négociation déguisée en examen médical. Chaque mot que vous prononcez, chaque geste que vous exécutez ou non, chaque douleur que vous montrez ou taisez pèse sur un montant. Vous n'avez pas à devenir méfiant ou tendu. Vous devez seulement comprendre l'enjeu et vous y préparer comme on prépare un rendez-vous important : en sachant ce qui va se dire et ce que vous voulez faire constater.

Lisez ce document entièrement, plusieurs jours avant l'examen. Reprenez-le la veille. Le jour venu, vous serez la personne la mieux préparée de la pièce.

1. Ce qu'est l'expertise médicale, et qui est le médecin en face de vous

Un examen pour mesurer, pas pour soigner

L'expertise médicale n'est pas un rendez-vous de soins. Le médecin expert ne va ni vous traiter ni vous prescrire quoi que ce soit. Sa mission est autre : évaluer les conséquences de l'accident sur votre corps et sur votre vie. Il traduit vos blessures en postes de préjudice, c'est-à-dire en catégories qui serviront à calculer votre indemnisation.

Cette traduction s'appuie sur une liste de référence utilisée par tous les praticiens du dommage corporel, la nomenclature Dintilhac. Il s'agit d'un outil de travail issu d'un rapport de 2005, qui recense les différents postes de préjudice, des douleurs endurées à la perte de qualité de vie. Cette nomenclature n'est pas une loi. Elle sert de langage commun pour décrire ce que vous avez perdu.

L'expert examine votre corps, lit votre dossier médical et vous interroge. À la fin, il rédige un rapport chiffré. C'est ce document qui aura une valeur dans la négociation ou devant le juge.

Comprenez bien ce que l'expert ne fait pas. Il ne vous soigne pas. Il ne juge pas les responsabilités de l'accident. Il ne fixe pas lui-même le montant de votre indemnisation. Son travail est purement médical : constater vos séquelles, les rattacher ou non à l'accident, et les évaluer poste par poste. Le chiffrage en euros viendra ensuite, à partir de son rapport. Cette division des rôles vous concerne directement. Devant l'expert, ne plaidez pas votre cause juridique et ne discutez pas des torts. Concentrez toute votre énergie sur une seule chose : faire constater l'étendue réelle de vos atteintes.

Avant et après la consolidation, deux mesures distinctes

Le rapport distingue deux périodes, séparées par la date de consolidation. Cette distinction commande l'ensemble de l'évaluation.

Avant la consolidation, l'expert mesure vos préjudices temporaires. Il évalue le déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire la gêne subie dans votre vie courante pendant la convalescence. Il apprécie les périodes où vous avez été totalement empêché et celles où vous avez été partiellement gêné. Il retient l'aide d'une tierce personne dont vous avez eu besoin durant cette période. Il évalue enfin les souffrances endurées avant la stabilisation.

Après la consolidation, l'expert mesure vos préjudices permanents. Il fixe le taux de déficit fonctionnel permanent, apprécie l'impact durable sur votre travail, retient le préjudice esthétique définitif, le préjudice d'agrément et, le cas

échéant, le besoin d'aide humaine à vie. Ces postes vous suivront des années. Ils pèsent le plus lourd dans l'indemnisation finale. C'est pourquoi la date retenue pour la consolidation n'est jamais un détail administratif.

Deux médecins très différents peuvent vous examiner

Le mot « expertise » recouvre deux situations que rien ne rend équivalentes. Savoir laquelle vous concerne change tout.

L'expertise amiable, mandatée par l'assureur. Dans la majorité des dossiers d'accident de la route, l'assureur du responsable organise lui-même l'examen. Il choisit le médecin. Il le rémunère. Ce médecin travaille régulièrement pour des compagnies d'assurance. Il n'est pas malhonnête par nature, mais il n'est pas neutre non plus. Il connaît l'intérêt de celui qui le paie. Une évaluation basse coûte moins cher à l'assureur. Vous devez aborder cet examen en le sachant.

L'expertise judiciaire, ordonnée par un juge. Lorsqu'un désaccord existe, ou dès que votre avocat le juge utile, un juge peut désigner un expert indépendant. Ce médecin est inscrit sur une liste de la cour d'appel. Il prête serment. Il ne dépend ni de vous ni de l'assureur. Sa mission est encadrée par une décision de justice qui fixe précisément les questions auxquelles il doit répondre. Ses conclusions ont un poids nettement supérieur. Le déroulé de cette expertise est plus formel : les parties échangent des pièces, votre avocat peut adresser des observations écrites auxquelles l'expert doit répondre, et le rapport final s'impose au débat judiciaire. Cette rigueur protège la victime, car elle interdit à l'expert d'écarter un point sans s'en expliquer.

La différence tient en une phrase. Devant le médecin de l'assureur, vous êtes face à une partie adverse polie. Devant l'expert judiciaire, vous êtes face à un tiers. Dans les deux cas, votre préparation reste la même, mais votre vigilance ne se relâche jamais devant le premier.

Une confusion fréquente mérite d'être levée. Le médecin de l'assureur est courtois, à l'écoute, et vous met à l'aise. Cette amabilité est réelle, mais elle ne change rien à sa position. Il est mandaté et payé par la partie qui devra vous indemniser. Un rapport favorable à la victime coûte plus cher à celui qui l'a désigné. Vous n'avez pas à vous méfier de la personne, vous devez rester lucide sur son rôle. La courtoisie de l'examen ne doit pas vous conduire à baisser la garde ni à minimiser vos douleurs pour « ne pas exagérer » devant quelqu'un d'aimable.

La consolidation, mot-clé de tout le processus

Un terme reviendra sans cesse : la consolidation. La consolidation est la date à laquelle votre état de santé se stabilise, c'est-à-dire le moment où les médecins estiment qu'aucune amélioration ni aggravation notable n'est plus attendue à court terme. Vous n'êtes pas forcément guéri. Vous êtes stabilisé.

Cette date est capitale. Avant la consolidation, on parle de préjudices temporaires, comme la gêne subie pendant la convalescence. Après la consolidation, on mesure les préjudices permanents, ceux qui vous accompagneront durablement. Le déficit fonctionnel permanent, souvent abrégé DFP, désigne la réduction définitive de vos capacités et des fonctions de votre corps, exprimée en pourcentage.

Un expert peut vous déclarer consolidé alors que vous souffrez encore. C'est parfois exact sur le plan médical. C'est parfois prématuré. Une consolidation fixée trop tôt fige des séquelles qui n'ont pas fini d'évoluer. C'est l'un des points que votre médecin-conseil et votre avocat surveilleront de près.

2. Votre droit d'être assisté par un médecin-conseil de victime

Un droit reconnu par la loi

Vous n'êtes pas obligé d'affronter seul le médecin de l'assureur. La loi vous le garantit. Dès sa première correspondance, l'assureur doit vous rappeler que vous pouvez vous faire assister, y compris par un médecin, lors de l'examen.

L'article L211-10 du code des assurances le formule ainsi :

« A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. »

Source : article L211-10 du code des assurances,

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795457 (identifiant Légifrance LEGIARTI000006795457).

Retenez deux mots de ce texte. « Libre choix » : c'est vous qui décidez du médecin qui vous accompagne, pas l'assureur. « À peine de nullité relative » : si l'assureur omet de vous informer de ce droit, la transaction signée ensuite peut être annulée. Ce droit n'est donc pas une formalité. C'est une garantie sanctionnée.

Ce qu'est un médecin-conseil de victime

Le médecin-conseil de victime est un médecin qui vous assiste et défend vos intérêts pendant l'expertise. Il connaît le dommage corporel aussi bien que le médecin de l'assureur. Il parle le même langage technique. Il repère une séquelle sous-évaluée, corrige un pourcentage trop bas et discute pied à pied avec l'expert adverse.

Sa présence rééquilibre l'examen. Sans lui, un dialogue s'installe entre un médecin rompu à l'exercice et une victime qui découvre tout. Avec lui, deux spécialistes s'expliquent, et vos droits sont défendus dans le vocabulaire qui compte. Ses honoraires font partie des frais que l'on cherche à faire prendre en charge dans l'indemnisation finale.

Comment le choisir : l'indépendance avant tout

Un principe domine ce choix. Votre médecin-conseil doit être indépendant des compagnies d'assurance. Un médecin qui travaille habituellement pour les assureurs ne peut pas défendre correctement une victime. Cherchez un praticien qui n'intervient que du côté des victimes.

Quelques repères concrets vous guident.

- **Vérifiez sa spécialisation en réparation du dommage corporel.** Ce champ est technique. Un médecin généraliste bienveillant ne suffit pas.
- **Demandez-lui pour qui il travaille.** La réponse doit être claire : uniquement pour les victimes, jamais pour les assureurs.
- **Assurez-vous qu'il se déplace aux expertises.** Son rôle se joue le jour de l'examen, à vos côtés, pas seulement sur pièces.

- **Laissez votre avocat vous orienter.** Un cabinet spécialisé en dommage corporel travaille avec des médecins-conseils indépendants dont il connaît le sérieux. C'est souvent la voie la plus sûre.

Ne confondez pas ce médecin avec votre médecin traitant. Votre médecin traitant vous soigne et fournit des pièces précieuses. Le médecin-conseil, lui, maîtrise l'expertise elle-même et son enjeu financier. Les deux rôles sont complémentaires et ne se remplacent pas.

Le rôle concret du médecin-conseil, le jour de l'examen

La présence de votre médecin-conseil change la nature même de l'examen. Voici ce qu'il fait concrètement à vos côtés.

Il prépare l'expertise avant le jour J. Il étudie votre dossier médical, repère les séquelles à mettre en avant et anticipe les points que l'expert adverse pourrait minimiser. Il vous explique le déroulé pour que rien ne vous surprenne.

Pendant l'examen, il assiste à l'entretien et à l'examen clinique. Il complète vos réponses lorsqu'une gêne mérite d'être précisée. Il veille à ce qu'aucune zone douloureuse ne soit oubliée. Il discute, dans le langage technique, les tests réalisés par l'expert et leurs résultats.

Au moment de conclure, il ne laisse pas passer une évaluation sous-estimée. Il conteste sur place un taux trop bas, une consolidation prématurée, un poste ignoré. Ses désaccords sont notés. Ils préparent les observations et les dires qui suivront.

Ce que vous risquez sans assistance

Sans médecin-conseil, l'examen se déroule à sens unique. Vous décrivez vos douleurs comme vous le pouvez, sans savoir lesquelles pèsent le plus. Vous ignorez si le taux annoncé est juste ou faible. Vous acceptez, faute de repères, un rapport que vous ne pouvez pas discuter techniquement. Beaucoup de sous-évaluations ne viennent pas d'une mauvaise foi de l'expert, mais simplement d'une victime seule qui n'a pas su, ou pas osé, faire valoir l'ampleur réelle de ses séquelles. L'assistance corrige ce déséquilibre.

3. Préparer la journée type que vous allez raconter

Pourquoi ce récit pèse autant que les radios

L'expert lit vos examens d'imagerie et vos comptes rendus. Mais une part majeure de votre préjudice ne se voit sur aucune radio. La douleur au réveil, la fatigue qui tombe à midi, la peur en voiture, l'aide dont vous avez besoin pour vous habiller : rien de tout cela n'apparaît sur un cliché. Cela ne se sait que si vous le dites.

L'expert va vous demander de décrire une journée ordinaire. Cette question paraît anodine. Elle est décisive. Un récit vague donne un préjudice vague. Un récit précis, heure par heure, rend visible la gêne réelle qui s'est installée dans votre vie.

Préparez ce récit à l'avance, par écrit, pour vous-même. Ne le récitez pas mécaniquement le jour de l'examen, mais ayez tout en tête. Voici la trame à travailler.

Comment se déroule concrètement l'examen

Savoir à quoi vous attendre réduit le stress et vous rend plus précis. L'expertise suit presque toujours le même déroulé.

D'abord vient un entretien. L'expert reprend les circonstances de l'accident, votre parcours de soins et vos antécédents. Il vous laisse décrire vos plaintes actuelles. Cette phase est le moment de votre récit préparé : c'est là que vous déroulez votre journée type.

Vient ensuite l'examen clinique. L'expert vous demande de vous dévêtir en partie pour examiner les zones atteintes. Il teste vos mouvements, vos articulations, votre force, vos réflexes. Il mesure des amplitudes, observe vos cicatrices, note votre façon de marcher ou de vous asseoir. Ne masquez pas une douleur par réflexe de politesse : si un geste vous fait mal, dites-le au moment où il vous fait mal.

Enfin, l'expert énonce ses premières conclusions, parfois oralement. Il évoque une date de consolidation, un taux, une évaluation des différents postes. Écoutez attentivement. Si un point vous paraît faux ou incomplet, c'est le moment de réagir, appuyé par votre médecin-conseil.

L'examen dure généralement entre trente minutes et une heure et demie, selon la complexité de vos blessures. Arrivez en avance, reposé, et prévoyez du temps après pour ne pas être pressé.

Voici la trame à travailler

Le matin et la toilette

Décrivez votre réveil. Dormez-vous jusqu'au bout de la nuit ou la douleur vous réveille-t-elle ? Combien de temps vous faut-il pour vous lever ? Avez-vous besoin de vous asseoir au bord du lit avant de tenir debout ?

Détaillez la toilette. Pouvez-vous entrer seul dans la douche ? Atteignez-vous vos pieds, votre dos, vos cheveux ? Avez-vous installé une barre d'appui, un tabouret ? Quelqu'un vous aide-t-il à vous laver ou à vous habiller ? Boutonner une chemise, nouer des lacets, enfiler des chaussettes : ces gestes simples révèlent une gêne que rien d'autre ne montre.

Le travail ou l'activité de la journée

Racontez votre journée d'activité, que vous travailliez ou non. Si vous travaillez, expliquez comment vous tenez votre poste. Devez-vous vous lever souvent ? Portez-vous encore des charges ? Avez-vous réduit votre temps ? Vos collègues compensent-ils certaines tâches ? Si vous êtes en arrêt, dites depuis quand et ce que vous ne pouvez plus faire.

Si vous ne travaillez pas, décrivez vos occupations habituelles. Les courses, le ménage, le jardinage, la conduite, la garde des enfants ou des petits-enfants. Précisez ce que vous avez abandonné et ce qui vous demande désormais un effort ou une aide.

Le soir et la nuit

Le soir révèle souvent la fatigue accumulée. Rentrez-vous épuisé ? Devez-vous vous allonger ? Renoncez-vous à des sorties, à un sport, à des loisirs que vous aimiez ? Ces renoncements portent un nom en droit du dommage corporel, le préjudice d'agrément, qui désigne l'impossibilité de pratiquer une activité de loisir ou de sport que vous exerciez avant l'accident.

La nuit compte autant. Décrivez votre sommeil. Vous réveillez-vous à cause de la douleur ? Devez-vous changer de position, prendre un médicament, dormir dans une autre pièce ? Un sommeil haché épuise et pèse sur tout le reste de la journée. Dites-le.

Pour préparer ce récit, une méthode simple aide beaucoup. Pendant la semaine qui précède l'examen, notez sur un carnet, jour après jour, les moments où votre état vous gêne. Une douleur au réveil, un geste impossible, une sortie annulée, une nuit coupée. Ces notes prises sur le vif valent mieux que des souvenirs reconstitués sous le stress. Elles vous donnent des exemples datés et concrets, exactement ce que l'expert retient. Vous n'aurez pas à tout mémoriser : il vous suffira de vous appuyer sur ce carnet le jour venu.

La règle d'or : ni minimiser, ni exagérer

Une seule ligne de conduite tient tout ce récit. Dites la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Ne minimisez pas. Beaucoup de victimes, par fierté ou par habitude de « faire avec », répondent « ça va » quand ça ne va pas. L'expert prend cette réponse au mot. « Ça va » se traduit par une séquelle légère. Décrivez vos difficultés telles qu'elles sont, sans les habiller de courage.

N'exagérez jamais. Un expert examine des dizaines de victimes chaque mois. Il repère immédiatement une plainte disproportionnée. Une seule exagération détectée jette le doute sur tout votre récit et se retourne contre vous. Votre crédibilité est votre meilleur atout. Elle repose sur l'exactitude.

Entre les deux se trouve la vérité utile : votre quotidien réel, décrit avec des faits concrets et des exemples précis. C'est cela que l'expert doit entendre.

Les erreurs les plus fréquentes à éviter

Certaines maladresses reviennent d'une expertise à l'autre. Les connaître, c'est déjà les éviter.

Faire bonne figure. Le jour de l'examen, beaucoup de victimes se présentent sous leur meilleur jour. Elles cachent leur fatigue, forcent un sourire, dissimulent une boiterie. Ce réflexe humain nuit à votre dossier. Venez tel que vous êtes réellement un jour ordinaire, sans jouer la forme que vous n'avez pas.

Répondre trop vite. Sous le stress, on répond avant d'avoir réfléchi. On dit « oui » pour aller vite, on minimise pour ne pas se plaindre. Prenez une seconde avant chaque réponse. Personne ne vous presse.

Oublier le retentissement psychologique. Les victimes parlent volontiers de leurs douleurs physiques et taisent leur mal-être. Or l'angoisse, les troubles du sommeil et la peur de reprendre la route sont des préjudices à part entière. Ne les gardez pas pour vous.

Sous-estimer l'aide des proches. Quand c'est votre conjoint ou vos enfants qui vous aident, vous n'y voyez pas une aide « officielle ». L'expert, lui, doit la mesurer. Décrivez cette aide familiale comme toute autre.

Se croire lié par ce qui est dit oralement. Une conclusion annoncée à voix haute en fin d'examen n'est pas définitive. Le rapport écrit se relit et se conteste. Ne repartez pas résigné parce qu'un chiffre vous a été énoncé.

Y aller seul et sans dossier. C'est l'erreur qui contient toutes les autres. Sans médecin-conseil et sans pièces, vous perdez la moitié de vos moyens. Ces deux appuis se préparent des semaines à l'avance.

4. Les 15 questions de l'expert, et comment y répondre

L'expert suit un fil logique. Ses questions couvrent l'accident, vos soins, votre douleur, vos capacités actuelles et votre vie. Elles ne sont pas des pièges. Elles servent à remplir chaque case de son évaluation. Mais une réponse pauvre laisse une case vide, et une case vide devient un préjudice non réparé.

Voici les 15 questions que vous entendrez presque à coup sûr, avec pour chacune la façon d'y répondre : honnêtement, complètement, sans piège. Lisez-les avant l'examen. Préparez, pour chacune, ce que vous voudrez dire. Le jour venu, vous ne serez pas pris au dépourvu et vous n'oublierez rien d'important.

1. Comment l'accident s'est-il produit ? Racontez les faits simplement, dans l'ordre. Ne cherchez pas à interpréter les responsabilités, ce n'est pas le rôle de l'expert. Tenez-vous en à ce que vous avez vécu et ressenti au moment du choc.

2. Quels ont été vos premiers soins et votre parcours médical ? Déroulez la chronologie : les secours, l'hôpital, les services traversés, les opérations, la rééducation. Appuyez-vous sur vos comptes rendus pour ne pas vous tromper de dates. La continuité de vos soins prouve la réalité de vos blessures.

3. Aviez-vous des antécédents médicaux avant l'accident ? Répondez avec une sincérité totale. Cacher un antécédent serait découvert et détruirait votre crédibilité. Mais précisez bien votre état avant l'accident : si une zone ne vous gênait pas dans la vie courante, dites-le clairement. L'enjeu est de distinguer ce qui vient de l'accident de ce qui préexistait.

4. Où avez-vous mal aujourd'hui, et comment décririez-vous cette douleur ? Nommez chaque zone douloureuse, une par une. Décrivez la nature de la douleur : brûlure, élancement, raideur, décharge. Indiquez son intensité et ses variations selon les moments et les efforts. N'en oubliez aucune par lassitude.

5. Vos douleurs sont-elles permanentes ou intermittentes ? Soyez précis. Une douleur de fond permanente et des crises ponctuelles ne se valent pas. Dites ce qui déclenche les pics : le froid, l'effort, la station debout, la fatigue. Ces détails nourrissent l'évaluation des souffrances endurées, terme qui désigne les douleurs physiques et morales subies à cause de l'accident.

6. Prenez-vous des traitements, et lesquels ? Listez tout : médicaments, doses, antidouleurs, somnifères, séances de kinésithérapie, suivi psychologique. Apportez vos ordonnances. Un traitement lourd et durable témoigne de l'intensité de vos séquelles.

7. Quelle est votre gêne dans les gestes de la vie quotidienne ? C'est ici que sert votre journée type préparée. Déroulez concrètement : la toilette, l'habillage, les courses, le ménage, la cuisine, la conduite. Donnez des exemples réels plutôt que des généralités. Chaque geste devenu difficile compte.

8. Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne ? Décrivez précisément toute aide reçue, familiale ou professionnelle. Qui vous aide, pour quoi, combien de temps par jour. Cette aide correspond au poste de la tierce personne, c'est-à-dire l'assistance d'un tiers rendue nécessaire par votre état. Ne la sous-estimez pas parce qu'elle vient d'un proche : elle se mesure quand même.

9. Avez-vous repris votre travail, et dans quelles conditions ? Expliquez votre situation professionnelle réelle. Reprise complète, partielle, aménagée, ou arrêt persistant. Décrivez les tâches que vous ne pouvez plus assurer, la fatigue, les aménagements de poste. L'impact professionnel est un préjudice majeur.

10. Quelles activités de loisir ou de sport avez-vous dû abandonner ? Citez ce que vous pratiquiez avant et ne pouvez plus faire. Sport, musique, bricolage, voyages, vie associative. Si vous étiez licencié dans un club ou pratiquiez régulièrement, dites-le, car cela documente votre préjudice d'agrément.

11. L'accident a-t-il laissé des cicatrices ou modifié votre apparence ? Montrez sans gêne toute cicatrice, déformation ou boiterie. Précisez si elle est visible, si elle vous complexe, si elle vous conduit à vous cacher. Cela relève du préjudice esthétique, qui répare l'altération de votre apparence physique.

12. Comment allez-vous sur le plan psychologique ? Ne taisez jamais le retentissement moral. Angoisse, troubles du sommeil, peur de reprendre la route, irritabilité, perte d'élan, suivi par un psychologue ou un psychiatre. Le préjudice psychique est réel et réparable. Le passer sous silence revient à l'effacer du rapport.

13. Votre vie de couple et votre vie familiale ont-elles changé ? Cette question intime est légitime dans ce cadre. Répondez avec la même honnêteté, en restant factuel. Les répercussions sur votre intimité et sur votre rôle au sein de la famille peuvent être prises en compte.

14. Selon vous, votre état est-il stabilisé ? Répondez selon votre ressenti réel. Si vous vous sentez encore en évolution, si un traitement est en cours ou une intervention prévue, dites-le. Cette réponse touche à la date de consolidation. Ne validez pas une stabilisation que vous ne ressentez pas.

15. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Ne répondez jamais « non » par réflexe. Cette question ouverte est une chance. Reprenez ce que vous auriez oublié : une douleur, une gêne, un renoncement, un moment difficile de la journée. C'est votre dernier mot au dossier avant qu'il ne se referme.

Un conseil traverse ces 15 réponses. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas chronométré. Réfléchissez avant de répondre. Et si votre médecin-conseil est présent, laissez-le compléter ou préciser un point technique : c'est précisément pour cela qu'il est là.

5. La liste des pièces à apporter

Un dossier complet donne à l'expert de quoi mesurer l'étendue exacte de vos préjudices. Une pièce manquante, c'est un préjudice qui risque de passer inaperçu. Rassemblez tout à l'avance, classé par ordre chronologique, et apportez des copies que vous pourrez laisser.

Les pièces sur l'accident - La copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie, que l'assureur doit vous communiquer sur simple demande. - Le constat amiable, si un constat a été rempli. - Tout élément décrivant les circonstances : plan, photographies, coordonnées de témoins.

Les pièces médicales - Le certificat médical initial, établi juste après l'accident. C'est une pièce essentielle : il fixe l'état de vos blessures d'origine. - L'ensemble de vos comptes rendus d'hospitalisation et opératoires. - Vos examens d'imagerie et leurs comptes rendus : radios, scanners, IRM, échographies. - Les comptes rendus de consultation de tous les spécialistes consultés. - Vos comptes rendus de rééducation et de kinésithérapie. - Toutes vos ordonnances, anciennes et actuelles. - Les certificats de votre médecin traitant décrivant votre évolution et vos séquelles. - Les bilans psychologiques ou psychiatriques, s'il en existe.

Les pièces sur votre vie professionnelle et personnelle - Vos arrêts de travail successifs. - Les justificatifs d'aménagement de poste, de reclassement ou de perte d'emploi. - Vos bulletins de salaire avant et après l'accident, pour objectiver une perte de revenus. - Les justificatifs des frais restés à votre charge : matériel médical, aménagement du logement ou du véhicule, transports pour vos soins. - Les justificatifs de l'aide reçue d'une tierce personne.

Vos écrits personnels - Le récit de votre journée type, préparé à partir de ce guide. - Une note listant vos douleurs, vos gênes et vos activités abandonnées, pour ne rien oublier sous le stress de l'examen.

Comment organiser ce dossier - Classez les pièces par ordre chronologique, du certificat médical initial jusqu'aux comptes rendus les plus récents. L'expert suit ainsi votre parcours sans se perdre. - Préparez un bordereau, c'est-à-dire une liste numérotée de toutes les pièces. Vous savez à tout moment ce que vous avez remis. - Apportez des copies destinées à rester au dossier, et gardez vos originaux. - Surlignez, sur une note à part, les éléments que vous jugez essentiels, pour les signaler si l'expert ne les relève pas.

Un dossier bien tenu produit un double effet. Il donne à l'expert la matière pour évaluer chaque poste. Il montre aussi une victime organisée et crédible, dont le récit s'appuie sur des documents et non sur des impressions.

Un mot sur les preuves. N'apportez que des documents réguliers et loyaux. Ne produisez jamais un enregistrement réalisé à l'insu d'une personne ni une pièce obtenue de façon déloyale : une telle preuve se retournerait contre vous. Si des proches peuvent témoigner de votre quotidien, une attestation écrite dans les formes légales a plus de valeur qu'un propos rapporté. Une attestation utile décrit des faits précisément constatés par son auteur, mentionne son identité et son lien avec vous, et respecte les conditions de forme prévues par la loi.

6. Après l'expertise : le rapport n'est pas une sentence

Beaucoup de victimes croient que tout se joue le jour de l'examen. C'est faux. Une phase capitale commence après, et vous y avez des droits. Le rapport peut être relu, discuté et complété.

Relire le rapport ligne à ligne

Vous recevez le rapport de l'expert. Lisez-le entièrement, plusieurs fois, avec votre médecin-conseil et votre avocat. Vérifiez trois choses.

D'abord, l'exactitude des faits. Les dates, le déroulé des soins, vos antécédents : une erreur matérielle se corrige. Ensuite, l'exhaustivité. Chaque douleur, chaque gêne, chaque activité perdue que vous aviez signalée figure-t-elle bien au rapport ? Un oubli est fréquent. Enfin, la cohérence de l'évaluation. Le taux de déficit permanent, la date de consolidation, l'évaluation des souffrances endurées et du préjudice esthétique correspondent-ils à votre réalité ?

Un rapport d'expertise amiable, rédigé par le médecin de l'assureur, appelle une vigilance particulière. Une évaluation trop basse est possible. Elle n'est pas définitive.

Formuler des observations

Si le rapport minimise vos séquelles, vous n'êtes pas contraint de l'accepter. Vous pouvez formuler des observations, c'est-à-dire des remarques écrites contestant ou complétant les conclusions de l'expert. Votre médecin-conseil les rédige dans le langage technique qui convient, en s'appuyant sur vos pièces médicales.

Ces observations obligent à rouvrir la discussion. Un point sous-évalué peut être revu. Une séquelle oubliée peut être réintégrée. C'est souvent à ce stade que se gagnent ou se perdent des postes entiers de préjudice.

Les dires : peser sur l'expertise judiciaire

Lorsque l'expertise est judiciaire, l'outil s'appelle le dire. Un dire est une observation écrite adressée officiellement à l'expert pendant sa mission, à laquelle il est tenu de répondre dans son rapport. Votre avocat rédige ce dire, appuyé par l'analyse de votre médecin-conseil.

Le dire est une arme précieuse. Il force l'expert à motiver sa position sur chaque point contesté. Un pourcentage discuté, une consolidation jugée prématurée, un préjudice ignoré : le dire met ces désaccords au dossier et engage l'expert à s'expliquer. Un rapport qui aurait glissé sur vos séquelles ne le peut plus dès lors qu'un dire l'interpelle.

Si le désaccord demeure

Un désaccord persistant ne vous ferme aucune porte. Vous pouvez refuser une évaluation amiable et demander en justice une nouvelle expertise, cette fois judiciaire et indépendante. Vous pouvez, si l'expertise était déjà judiciaire, solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise. Rien ne vous oblige à signer une indemnisation fondée sur un rapport que vous estimez faux.

Prenez le temps avant toute signature

Une dernière prudence s'impose. Après l'expertise et l'évaluation, l'assureur vous adressera peut-être une proposition d'indemnisation. Ne signez rien dans la précipitation. Un accord signé se discute mal ensuite. Faites relire toute proposition par votre avocat avant de l'accepter. Une offre spontanée n'est pas toujours à la hauteur de vos préjudices réels : dans la pratique, les premières offres se révèlent souvent nettement inférieures à ce qu'une victime assistée obtient au terme de la discussion. Prendre le temps de comparer l'offre à la réalité de votre dossier n'est jamais une perte de temps.

Cette dernière idée résume tout ce document. L'expertise n'est pas une fin. C'est une étape, encadrée par des droits que vous pouvez exercer. Bien préparée, bien assistée, bien relue, elle devient l'appui de votre indemnisation au lieu d'en être le plafond.

Lexique

- **Consolidation** : date à laquelle votre état de santé se stabilise, sans amélioration ni aggravation notable attendue à court terme. Elle sépare les préjudices temporaires des préjudices permanents.
- **Déficit fonctionnel temporaire (DFT)** : réduction de vos capacités pendant la période de convalescence, avant la consolidation.
- **Déficit fonctionnel permanent (DFP)** : réduction définitive de vos capacités après la consolidation, exprimée en pourcentage.
- **Expertise amiable** : examen organisé et rémunéré par l'assureur, réalisé par un médecin qu'il choisit. Non neutre.
- **Expertise judiciaire** : examen confié par un juge à un expert indépendant inscrit près la cour d'appel, dont la mission est fixée par une décision de justice.

- **Médecin-conseil de victime** : médecin spécialisé en dommage corporel, indépendant des assureurs, qui vous assiste pendant l'expertise et défend l'exactitude de l'évaluation.
- **Souffrances endurées** : douleurs physiques et morales subies du fait de l'accident.
- **Préjudice esthétique** : altération de votre apparence physique (cicatrices, déformation, boiterie).
- **Préjudice d'agrément** : impossibilité de pratiquer une activité de loisir ou de sport exercée avant l'accident.
- **Tierce personne** : assistance d'un tiers rendue nécessaire par votre état, qu'elle soit familiale ou professionnelle.
- **Observations** : remarques écrites contestant ou complétant les conclusions de l'expert.
- **Dire** : observation écrite adressée officiellement à l'expert judiciaire pendant sa mission, à laquelle il doit répondre.
- **Nomenclature Dintilhac** : liste de référence des postes de préjudice corporel, utilisée comme outil de travail commun.

Votre prochaine étape Avant votre expertise, contactez un avocat spécialisé en dommage corporel pour être orienté vers un médecin-conseil indépendant qui vous assistera le jour de l'examen.

Le cabinet LEXVOX AVOCATS accompagne les victimes d'accident et de dommage corporel en région PACA. Me Patrice Humbert, spécialiste du dommage corporel, prépare avec vous chaque expertise et travaille avec des médecins-conseils indépendants des assureurs. La première consultation, de 30 minutes, est gratuite. Vous pouvez joindre le standard au 04 90 54 58 10 ou prendre contact via <https://lexvox-victime.com>. Le cabinet dispose de quatre bureaux en PACA : Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane.

DOCUMENT 02

PALIER 2 : LE KIT EXPERTISE

La grille d'auto-recensement des 20 postes

Ce que ce document va vous permettre - Passer en revue, un par un, les 20 postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac et repérer ceux qui vous concernent. - Comprendre en une phrase chaque terme technique (DFT, DFP, tierce personne, incidence professionnelle) sans jargon inutile. - Constituer, poste par poste, la liste de vos preuves pour ne rien oublier au moment de l'évaluation.

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Comment utiliser cette grille

Après un accident, votre corps et votre vie ont été atteints de multiples façons. Le droit français ne répare pas un préjudice global et flou. Il répare des postes précis, identifiés un par un. C'est le rôle de la nomenclature Dintilhac.

La nomenclature Dintilhac est une liste de référence des postes de préjudice corporel, issue d'un rapport de groupe de travail publié en 2005. Ce n'est pas une loi. C'est un outil de classement, constamment utilisé par les juges, les assureurs et les avocats pour ne rien laisser de côté. La citer ne fonde aucun droit à elle seule, mais elle structure toute la discussion de votre indemnisation.

Cette grille reprend les 20 postes de la victime directe. Ils se répartissent en cinq familles. Deux notions traversent tout le document. Premièrement, la distinction entre préjudice patrimonial (ce qui touche votre argent et votre patrimoine) et préjudice extra-patrimonial (ce qui touche votre personne, votre corps, vos souffrances). Deuxièmement, la consolidation : c'est la date, fixée par un médecin, à laquelle votre état de santé se stabilise et n'évolue plus de façon prévisible. Avant la consolidation, un préjudice est dit temporaire. Après, il est dit permanent.

Pour chaque poste, répondez par oui ou par non aux questions. Un seul oui suffit à cocher le poste comme vous concernant. Notez ensuite, dans la colonne « mes preuves », les documents que vous détenez déjà ou que vous devez réunir. Ne jetez rien : une facture, un arrêt de travail, une photo datée ou une attestation de proche peuvent tous servir.

Un mot sur les attestations de proches. L'article 202 du code de procédure civile encadre leur forme : le témoin relate des faits qu'il a personnellement constatés, indique son identité, son lien avec vous, et sait qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales. Une attestation bien rédigée vaut une preuve solide. Ne demandez jamais à un proche d'écrire autre chose que ce qu'il a réellement vu.

Deux réflexes valent pour tous les postes. D'abord, datez et conservez : une facture non datée perd la moitié de sa force, une photographie sans date se discute. Ensuite, pensez au « avant » autant qu'au « après ». Pour prouver ce que l'accident vous a retiré (un sport, un métier, une aisance de mouvement), il faut pouvoir montrer ce que vous faisiez avant. Une licence sportive, un contrat de travail, des photographies de vacances peuvent servir de point de comparaison.

Enfin, cette grille couvre les 20 postes de la victime directe, c'est-à-dire vous. Si l'accident a également affecté vos proches (un conjoint qui vous assiste, un enfant privé de votre présence, une famille endeuillée), sachez que la nomenclature prévoit des postes distincts pour ces victimes dites « par ricochet ». Ils ne sont pas comptés dans les 20 postes ci-dessous, mais ils existent : signalez cette situation à votre avocat, elle ouvre des droits propres à vos proches.

Famille 1 : préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Ces postes concernent les dépenses et pertes d'argent survenues entre l'accident et la consolidation.

Poste 1 : Dépenses de santé actuelles (DSA)

Frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et paramédicaux engagés avant la consolidation, y compris la part qui reste à votre charge après remboursement.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Avez-vous engagé des frais médicaux ou d'hospitalisation depuis l'accident ?		
Une part de ces frais est-elle restée à votre charge après la Sécurité sociale et la mutuelle ?		
Avez-vous payé des soins non remboursés (ostéopathie, séances complémentaires) ?		
Conservez-vous les décomptes de votre organisme et de votre mutuelle ?		

Poste 2 : Frais divers (FD)

Tous les frais liés à l'accident autres que les soins : transports médicaux, frais de garde d'enfants, honoraires d'un médecin conseil, aide à domicile provisoire avant consolidation.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Avez-vous payé des trajets pour vous rendre à des rendez-vous médicaux ?		
Avez-vous eu recours à une aide ménagère ou à une garde d'enfants à cause de l'accident ?		
Avez-vous consulté un médecin conseil pour vous assister lors d'une expertise ?		
Avez-vous engagé d'autres frais exceptionnels directement causés par l'accident ?		

Poste 3 : Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

Pertes de revenus subies pendant la période d'arrêt, avant la consolidation, du fait de l'incapacité de travailler.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Avez-vous été en arrêt de travail à la suite de l'accident ?		
Vos revenus ont-ils baissé pendant cet arrêt (indemnités inférieures au salaire) ?		
Si vous êtes indépendant, votre activité a-t-elle été réduite ou interrompue ?		
Avez-vous perdu des primes, heures supplémentaires ou missions à cause de l'arrêt ?		

Famille 2 : préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Ces postes concernent les conséquences financières durables, une fois votre état stabilisé.

Poste 4 : Dépenses de santé futures (DSF)

Frais médicaux et paramédicaux répétés ou viagers, prévisibles après la consolidation : appareillage, prothèses, rééducation à vie, renouvellement de matériel.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Devrez-vous suivre des soins réguliers après votre consolidation ?		
Portez-vous une prothèse ou un appareillage à renouveler périodiquement ?		
Un médecin a-t-il prévu des séances de rééducation durables ?		

Poste 5 : Frais de logement adapté (FLA)

Coût des aménagements de votre domicile rendus nécessaires par le handicap, ou du surcoût d'un logement adapté.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Votre logement doit-il être aménagé (rampe, douche, élargissement des portes) ?		
Devez-vous déménager pour un logement accessible ?		
Avez-vous des devis ou factures de travaux d'adaptation ?		

Poste 6 : Frais de véhicule adapté (FVA)

Coût de l'adaptation de votre véhicule ou du surcoût d'un véhicule permettant de conserver une autonomie de déplacement.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Votre véhicule doit-il être équipé de commandes adaptées ?		
Avez-vous besoin d'un véhicule permettant le transport d'un fauteuil ?		
Détenez-vous des devis d'aménagement automobile ?		

Poste 7 : Assistance par tierce personne (ATP)

La tierce personne est l'aide humaine, professionnelle ou familiale, dont vous avez besoin pour les actes de la vie quotidienne (se laver, s'habiller, se déplacer, préparer les repas) que vous ne pouvez plus accomplir seul.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Avez-vous besoin d'aide pour vous laver, vous habiller ou vous nourrir ?		
Un proche vous assiste-t-il chaque jour pour des gestes du quotidien ?		
Employez-vous une aide à domicile de façon durable ?		
Un médecin a-t-il évalué le nombre d'heures d'aide nécessaires ?		

Poste 8 : Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Pertes de revenus durables, après consolidation, dues à l'impossibilité de reprendre votre emploi ou à une reprise à temps réduit.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Êtes-vous dans l'incapacité de reprendre votre métier d'avant ?		
Avez-vous dû réduire votre temps de travail durablement ?		
Avez-vous été licencié ou déclaré inapte à la suite de l'accident ?		
Vos revenus futurs sont-ils durablement diminués ?		

Poste 9 : Incidence professionnelle (IP)

L'incidence professionnelle répare les conséquences durables sur votre vie de travail qui ne sont pas de simples pertes de salaire : pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché de l'emploi, perte de chance de promotion, abandon d'un métier choisi.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Votre travail est-il devenu plus pénible ou plus fatigant ?		
Avez-vous perdu des perspectives d'évolution ou de promotion ?		
Êtes-vous devenu moins compétitif pour retrouver un emploi ?		
Avez-vous dû renoncer au métier que vous exerciez ou visiez ?		

Poste 10 : Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

Retard, redoublement, réorientation forcée ou renonciation à des études ou à une formation, causés par l'accident.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Avez-vous perdu une année scolaire ou universitaire à cause de l'accident ?		
Avez-vous dû abandonner ou changer de formation ?		
Avez-vous renoncé à un projet d'études que vous poursuiviez ?		

Famille 3 : préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Ces postes concernent les atteintes à votre personne subies avant la consolidation.

Poste 11 : Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Le déficit fonctionnel temporaire est la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période de soins, avant consolidation : perte de qualité de vie, séparation d'avec les proches, impossibilité de tenir votre rôle habituel.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Avez-vous été hospitalisé ou alité pendant une période ?		
Votre autonomie quotidienne a-t-elle été réduite pendant les soins ?		
Avez-vous été privé de vos activités habituelles pendant votre convalescence ?		

Poste 12 : Souffrances endurées (SE)

Toutes les souffrances physiques et psychiques éprouvées entre l'accident et la consolidation : douleurs, interventions, rééducation, angoisse.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Avez-vous subi des douleurs physiques importantes depuis l'accident ?		
Avez-vous subi des opérations ou des soins pénibles ?		
Éprouvez-vous une souffrance psychique (angoisse, troubles du sommeil) ?		
Suivez-vous un accompagnement psychologique ?		

Poste 13 : Préjudice esthétique temporaire (PET)

Altération de l'apparence physique pendant la période de soins : plâtre visible, cicatrices en cours de guérison, boiterie provisoire, avant consolidation.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Votre apparence a-t-elle été altérée pendant votre convalescence ?		
Avez-vous porté un dispositif visible (attelle, fixateur, pansements) ?		
Avez-vous des photographies datées de cette période ?		

Famille 4 : préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Ces postes concernent les atteintes durables à votre personne, une fois l'état stabilisé.

Poste 14 : Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Le déficit fonctionnel permanent est la réduction définitive de vos capacités après consolidation : séquelles physiques ou psychiques, douleurs persistantes, perte de qualité de vie au quotidien. Il est exprimé par le médecin en taux, de 0 à 100 %.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Conservez-vous des séquelles définitives après votre consolidation ?		
Ressentez-vous des douleurs qui persistent malgré la fin des soins ?		
Vos gestes quotidiens restent-ils limités de façon durable ?		
Un médecin a-t-il évoqué un taux d'incapacité permanente ?		

Poste 15 : Préjudice d'agrément (PA)

Impossibilité définitive de pratiquer une activité de loisir, sportive ou culturelle que vous exerciez régulièrement avant l'accident.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Avez-vous dû renoncer à un sport que vous pratiquiez ?		
Avez-vous abandonné un loisir ou une activité culturelle régulière ?		
Pouvez-vous prouver que vous pratiquiez cette activité avant l'accident ?		

Poste 16 : Préjudice esthétique permanent (PEP)

Altération définitive de votre apparence physique après consolidation : cicatrices, amputation, boiterie durable.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Conservez-vous des cicatrices ou marques visibles définitives ?		
Votre démarche ou votre silhouette a-t-elle changé durablement ?		
Portez-vous une prothèse visible ?		

Poste 17 : Préjudice sexuel (PS)

Atteinte durable à la fonction sexuelle : perte de capacité physique, difficulté à procréer, ou atteinte au plaisir.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
L'accident a-t-il porté atteinte à votre vie intime de façon durable ?		
Éprouvez-vous des difficultés physiques directement liées à l'accident ?		
Votre capacité à concevoir un enfant a-t-elle été affectée ?		

Poste 18 : Préjudice d'établissement (PE)

Le préjudice d'établissement est la perte d'espoir de réaliser un projet de vie familiale normal : fonder un foyer, se marier, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Le handicap compromet-il votre projet de fonder une famille ?		
Votre vie de couple ou familiale a-t-elle été durablement bouleversée ?		
Étiez-vous engagé dans un projet de vie que l'accident a interrompu ?		

Poste 19 : Préjudices permanents exceptionnels (PPE)

Préjudices atypiques, non couverts par les autres postes, liés à une situation ou à un événement particulier (par exemple un préjudice spécifique à certaines catastrophes ou circonstances rares).

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
Subissez-vous une conséquence particulière qu'aucun autre poste ne décrit ?		
Votre situation présente-t-elle un caractère exceptionnel lié à l'accident ?		
Pouvez-vous décrire précisément cette conséquence par écrit ?		

Famille 5 : préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

Poste 20 : Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)

Préjudices résultant d'une maladie évolutive, contractée ou révélée à l'occasion de l'accident, dont l'aggravation est prévisible dans le temps et qui ne se stabilise pas comme les autres séquelles.

QUESTION	OUI / NON	MES PREUVES
L'accident a-t-il révélé ou déclenché une pathologie évolutive ?		
Un médecin a-t-il annoncé une aggravation prévisible de votre état ?		
Vivez-vous dans la crainte médicalement fondée d'une dégradation future ?		
Disposez-vous d'un compte rendu médical décrivant cette évolution ?		

Récapitulatif : votre carte des 20 postes

FAMILLE	POSTES CONCERNÉS (NUMÉROS)
Patrimoniaux temporaires	1 DSA, 2 FD, 3 PGPA
Patrimoniaux permanents	4 DSF, 5 FLA, 6 FVA, 7 ATP, 8 PGPF, 9 IP, 10 PSU
Extra-patrimoniaux temporaires	11 DFT, 12 SE, 13 PET
Extra-patrimoniaux permanents	14 DFP, 15 PA, 16 PEP, 17 PS, 18 PE, 19 PPE
Évolutifs	20 PEV

Comptez les postes que vous avez cochés. Il n'existe pas de « bon » nombre. Une victime peut être concernée par trois postes, une autre par quinze. L'important est qu'aucun poste réel ne soit oublié : un poste non identifié est un poste non réparé.

Deux erreurs reviennent souvent chez les victimes qui préparent seules leur dossier. La première est de tout ramener à la douleur physique et d'oublier les postes patrimoniaux : les frais de transport, l'aide d'un proche, les revenus perdus se chiffrent et se prouvent. La seconde est de négliger l'avenir : beaucoup de victimes ne pensent qu'aux dépenses déjà engagées et laissent de côté les postes permanents (dépenses de santé futures, incidence professionnelle, tierce personne), qui pèsent souvent le plus lourd dans une réparation intégrale. Relisez votre grille avec ces deux angles morts en tête.

Gardez aussi à l'esprit que la consolidation est un point de bascule décisif. Tant qu'elle n'est pas fixée, vos préjudices permanents ne peuvent pas être évalués définitivement. Une évaluation menée trop tôt, avant que votre état ne soit stabilisé, risque de sous-estimer durablement vos droits. La date de consolidation relève du médecin, jamais de l'assureur seul.

Lexique des termes employés

- **Consolidation** : date, fixée par un médecin, à laquelle votre état de santé se stabilise. Elle sépare les préjudices temporaires des préjudices permanents.
- **Patrimonial / extra-patrimonial** : le préjudice patrimonial touche votre argent et votre patrimoine ; le préjudice extra-patrimonial touche votre personne, votre corps, vos souffrances.
- **DFT (déficit fonctionnel temporaire)** : gêne dans les actes de la vie courante pendant la période de soins, avant consolidation.
- **DFP (déficit fonctionnel permanent)** : réduction définitive de vos capacités après consolidation, exprimée par le médecin en taux de 0 à 100 %.
- **Tierce personne** : aide humaine nécessaire pour accomplir les gestes de la vie quotidienne que vous ne pouvez plus faire seul.
- **Incidence professionnelle** : conséquences durables sur votre vie de travail autres que la simple perte de salaire (pénibilité, dévalorisation, perte de promotion).
- **Préjudice d'agrément** : impossibilité de poursuivre une activité de loisir ou de sport pratiquée avant l'accident.

- **Préjudice d'établissement** : perte de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale normal en raison du handicap.
- **Nomenclature Dintilhac** : liste de référence des postes de préjudice corporel, outil de classement utilisé par la pratique et les juges, sans valeur de loi propre.

Votre prochaine étape Rassemblez dans une seule chemise toutes les preuves notées dans la colonne « mes preuves », classées par numéro de poste. Ce dossier sera la base de votre évaluation.

Une grille remplie ne vaut pas une expertise. L'évaluation de chaque poste, la fixation de la consolidation et la discussion des taux relèvent d'un travail d'avocat et de médecin. Si vous souhaitez confronter votre grille à un regard spécialisé, le cabinet LEXVOX AVOCATS propose une consultation initiale gratuite de 30 minutes. Vous exposez votre situation, vous repartez avec un premier repère, sans engagement. Standard : 04 90 54 58 10. Site : <https://lexvox-victime.com>. Quatre bureaux en PACA : Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles, Marignane.

DOCUMENT 03

PALIER 2 : LE KIT EXPERTISE

Le tableau tierce personne

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre ce qu'est la tierce personne et pourquoi ce poste est souvent le plus lourd de votre indemnisation. - Compter vous-même, acte par acte et en minutes, l'aide dont vous avez besoin chaque semaine, à l'aide d'un tableau à remplir. - Faire reconnaître l'aide apportée gratuitement par vos proches et la documenter avec une attestation conforme à la loi.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

1. Qu'est-ce que la tierce personne ?

La tierce personne est l'aide humaine dont vous avez besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne que votre état, depuis l'accident, ne vous permet plus d'accomplir seul. C'est la définition à retenir. Il ne s'agit pas d'un soin médical. Il s'agit d'une présence, d'un geste, d'un accompagnement.

Cette aide couvre les gestes les plus simples. Se laver. S'habiller. Préparer un repas. Se déplacer. Faire ses courses. Tenir son logement. Gérer ses papiers. Quand une blessure vous prive de ces gestes, quelqu'un doit les faire à votre place ou avec vous. Ce besoin a une valeur. Le droit de la réparation du dommage corporel l'appelle « assistance par tierce personne ».

Ce poste figure dans la nomenclature Dintilhac, qui est la liste de référence des postes de préjudice corporel utilisée par les experts et les tribunaux. Cette nomenclature est un outil de travail. Elle distingue notamment l'aide dont vous avez besoin avant votre consolidation, pendant la phase de soins, et l'aide définitive dont vous aurez besoin après, une fois votre état stabilisé.

La consolidation est le moment où votre état de santé n'évolue plus, où les lésions se sont fixées. Avant ce moment, on parle d'aide temporaire. Après, d'aide permanente. Les deux se comptent, mais séparément. La méthode de comptage, elle, est la même.

Pourquoi ce document insiste-t-il autant sur ce poste ? Parce qu'il est souvent le plus important en valeur, et parce qu'il est le plus souvent sous-estimé dans les offres reçues. Une aide de quelques heures par jour, comptée sur des années de vie, représente un enjeu considérable. Un besoin oublié dans le décompte, c'est un besoin qui ne sera jamais indemnisé.

Ce document ne vous donne aucun montant. Il vous apprend à compter votre besoin. Le chiffrage relève de votre avocat et de l'expertise médicale.

2. La méthode : compter en minutes, acte par acte

L'erreur la plus fréquente est de raisonner par impression. « J'ai besoin d'aide le matin. » Cette phrase ne se défend pas. Ce qui se défend, c'est un décompte précis : tel acte, tel nombre de minutes, tel nombre de fois par jour ou par semaine.

La méthode consiste donc à découper votre journée en actes concrets, puis à mesurer, pour chacun, le temps d'aide réellement nécessaire. Vous ne comptez pas le temps que met la tâche. Vous comptez le temps pendant lequel une autre personne doit vous aider ou faire à votre place.

Voici les grandes familles d'actes à examiner. Passez-les en revue une par une, honnêtement.

La toilette. Se laver le corps, se doucher, se coiffer, se raser, prendre soin de sa peau. Comptez le temps d'aide au lavage, à l'entrée et à la sortie de la douche, au séchage. Cet acte revient chaque jour.

L'habillage et le déshabillage. Enfiler un vêtement, boutonner, lacer, mettre des chaussures, poser une orthèse ou un bas de contention. Comptez le matin et le soir. Certaines pièces sont impossibles à mettre seul avec un bras ou une épaule atteints.

Les repas. Préparer à manger, couper les aliments, parfois aider à porter les couverts. Distinguez la préparation, qui peut demander une longue présence, et l'aide à la prise du repas elle-même. Ces gestes reviennent plusieurs fois par jour.

Les courses. Prévoir, se déplacer jusqu'au magasin, porter, ranger. Une charge lourde interdite, une marche impossible, et l'acte entier bascule sur un tiers. Comptez le temps réel, y compris les trajets.

Le ménage et l'entretien du logement. Nettoyer, passer l'aspirateur, changer les draps, étendre le linge, entretenir. Certains de ces gestes demandent de se baisser, de porter, de lever les bras. Comptez ce que vous ne pouvez plus assurer.

Les trajets et déplacements. Vous conduire à un rendez-vous médical, à la rééducation, à une démarche. Si vous ne pouvez plus conduire ou prendre seul les transports, une personne vous accompagne. Comptez la présence complète, aller et retour compris.

L'aide administrative. Lire, comprendre et remplir des courriers, gérer les dossiers, téléphoner aux organismes. Après un traumatisme, en particulier crânien, cette aide est réelle et souvent oubliée. Comptez le temps d'assistance nécessaire.

Pour chaque acte, posez-vous trois questions simples. Puis-je le faire seul, aujourd'hui ? Combien de fois par jour ou par semaine ? Combien de minutes d'aide humaine à chaque fois ? La réponse à ces trois questions, c'est votre décompte.

Un principe de sincérité doit vous guider. Ne gonflez rien. Un décompte exagéré se retourne contre vous à l'expertise. Un décompte juste, précis et daté, tient. Notez ce que vous vivez vraiment, semaine après semaine.

Deux formes d'aide coexistent, et vous devez les distinguer. Il y a l'aide active, celle où une personne fait un geste à votre place ou avec vous : elle vous lave, elle coupe vos aliments, elle porte vos courses. Il y a aussi la présence de surveillance, celle où une personne doit rester disponible parce que vous ne pouvez pas être laissé seul en sécurité. Cette seconde forme se rencontre notamment après un traumatisme sévère. Elle se compte différemment, sur des plages plus longues, et mérite d'être signalée à part dans vos notes.

Pensez enfin à séparer clairement la période avant consolidation et la période après. Tant que votre état évolue, votre besoin d'aide évolue aussi. Un besoin intense les premières semaines peut décroître ensuite, ou au contraire se stabiliser à un niveau durable. Datez chaque tableau. Une victime qui peut montrer comment son besoin a changé dans le temps présente un dossier bien plus crédible qu'une estimation figée et globale.

3. Votre modèle hebdomadaire à remplir

Le tableau ci-dessous est votre outil de travail. Remplissez-le sur une semaine ordinaire, représentative de votre quotidien actuel. Indiquez pour chaque acte le nombre de minutes d'aide par occurrence, le nombre de fois dans la semaine, puis le total.

Un conseil de méthode : tenez ce tableau en temps réel pendant sept jours plutôt que de le reconstituer de mémoire. Vous serez plus juste. Datez-le. Gardez-le. Refaites-le si votre état évolue.

ACTE DE LA VIE QUOTIDIENNE	MINUTES D'AIDE PAR FOIS	NOMBRE DE FOIS / SEMAINE	TOTAL MINUTES / SEMAINE	QUI VOUS AIDE
Toilette (douche, coiffure, rasage)				
Habillage et déshabillage				
Préparation et prise des repas				
Courses (déplacement, port, rangement)				
Ménage et entretien du logement				
Trajets et accompagnements (soins, rendez-vous)				
Aide administrative (courriers, dossiers, appels)				
Autre besoin (à préciser)				
Total hebdomadaire				

Quelques repères pour bien l'utiliser. La colonne « minutes par fois » mesure la durée d'aide, pas la durée de la tâche. La colonne « qui vous aide » sert à identifier les personnes qui pourront attester plus tard. Le total hebdomadaire vous donne une image concrète de votre besoin, que votre avocat et le médecin expert pourront ensuite examiner et discuter.

Ce tableau ne fixe aucun droit à lui seul. Il prépare et documente. Il transforme un ressenti diffus en éléments vérifiables. C'est exactement ce qui manque le plus souvent dans les dossiers montés sans méthode.

4. L'aide de vos proches compte, même gratuite

Voici un point que beaucoup de victimes ignorent, et qui change tout. L'aide apportée par un membre de votre famille, sans rémunération, est indemnisable. Le fait qu'un conjoint, un parent, un enfant vous assiste par affection et sans facture ne prive pas cette aide de sa valeur.

C'est une jurisprudence constante. La réparation de la tierce personne n'est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépense. Elle n'est pas réduite parce que l'aide est assurée par un proche plutôt que par un professionnel salarié. Le besoin existe, il est réel, et il ouvre droit à réparation, quelle que soit la personne qui le satisfait.

Cette règle protège les familles. Sans elle, seules les victimes ayant les moyens de salarier une aide extérieure seraient indemnisées. Le droit refuse cette logique. L'effort d'un proche, son temps, sa fatigue, l'organisation bouleversée du foyer, tout cela a une valeur que la réparation doit prendre en compte.

Pour vous, la conséquence est pratique. N'excluez jamais du tableau l'aide apportée par vos proches. Au contraire, identifiez-la précisément. Notez qui fait quoi, à quel moment, pendant combien de temps. Cette aide familiale, souvent la plus constante et la plus étendue, doit figurer dans votre décompte au même titre qu'une aide professionnelle.

Cette aide a un coût invisible pour votre foyer. Un proche qui réduit son activité, qui renonce à des heures, qui réorganise sa vie autour de la vôtre, subit une charge bien réelle. Le droit de la réparation ne demande pas que cette charge ait été facturée pour la reconnaître. Il demande qu'elle soit établie. Votre rôle, et celui de vos proches, consiste donc à la rendre visible et vérifiable, par des notes tenues au fil des jours et par des attestations.

Une précision utile pour éviter un malentendu fréquent. Le versement éventuel de certaines prestations sociales ou allocations liées à votre situation n'efface pas ce poste. Ces questions de coordination sont techniques et relèvent de l'analyse de votre avocat. Ce que vous avez à faire aujourd'hui reste simple : documenter le besoin, sans vous censurer au motif qu'une aide a été gratuite ou qu'une allocation existe.

Mais une aide non facturée doit être prouvée autrement que par une facture. C'est là qu'intervient l'attestation de vos proches.

5. L'attestation de vos proches, conforme à la loi

Pour établir la réalité de l'aide reçue, vos proches peuvent rédiger une attestation écrite. Ce document a une valeur devant l'expert et, s'il le faut, devant le juge. Mais il n'a cette valeur que s'il respecte une forme précise.

Cette forme est fixée par l'article 202 du code de procédure civile. Voici son texte exact.

« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »

Source du texte : article 202 du code de procédure civile,

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410330

Retenez trois exigences essentielles. L'attestation relate des faits personnellement constatés, pas une opinion. Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur, donc manuscrite. Elle mentionne le lien de parenté avec vous, qui ne la disqualifie pas mais doit être déclaré. Une pièce d'identité signée y est annexée.

Voici un modèle que votre proche peut recopier de sa main, en l'adaptant à sa situation.

Modèle d'attestation (à recopier à la main)

Je soussigné(e) [nom, prénoms], né(e) le [date] à [lieu de naissance], demeurant à [adresse complète], profession [profession], [lien avec vous, par exemple : conjoint, parent, enfant de la victime].

Atteste sur l'honneur des faits suivants, que j'ai personnellement constatés.

Depuis l'accident survenu le [date], j'aide [nom de la victime] dans les actes de sa vie quotidienne. [Décrivez concrètement les gestes accomplis, les moments de la journée, la fréquence et la durée. Par exemple : chaque matin, j'aide à la douche et à l'habillage pendant environ vingt minutes ; je prépare les repas ; je conduis aux rendez-vous de rééducation deux fois par semaine.]

J'établis la présente attestation en vue de sa production en justice. J'ai connaissance de ce qu'une fausse attestation de ma part m'expose à des sanctions pénales.

Fait à [lieu], le [date]. [Signature manuscrite]

(Joindre une copie signée d'une pièce d'identité.)

Ce modèle est un point de départ. Le contenu doit décrire votre réalité, sans exagération. Plusieurs proches peuvent attester chacun de leur côté. Des attestations concordantes, précises et datées, forment un dossier solide.

Lexique

Tierce personne : aide humaine nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne que votre état ne permet plus d'assurer seul.

Consolidation : moment où votre état de santé se stabilise et n'évolue plus. Il sépare l'aide temporaire de l'aide permanente.

Aide temporaire : aide nécessaire pendant la période de soins, avant la consolidation.

Aide permanente : aide nécessaire après la consolidation, une fois l'état stabilisé.

Nomenclature Dintilhac : liste de référence des postes de préjudice corporel, utilisée comme outil de travail par les experts et les tribunaux.

Attestation : déclaration écrite d'un témoin relatant des faits qu'il a personnellement constatés, dans la forme fixée par l'article 202 du code de procédure civile.

Votre prochaine étape Remplissez le tableau hebdomadaire sur sept jours consécutifs, dès cette semaine, et demandez à chacun de vos proches aidants de préparer son attestation.

Le poste tierce personne se gagne ou se perd sur la précision de votre préparation. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié à la réparation du dommage corporel, accompagne les victimes dans la construction de ce décompte et sa discussion à l'expertise. Si vous souhaitez faire relire votre tableau et vos attestations, une première consultation permet d'en parler et d'envisager la suite, sans engagement.

Le calculateur de pertes de gains

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre la méthode « revenus avant, revenus après » pour chiffrer ce que l'accident vous a coûté en argent. - Distinguer trois pertes différentes que les assureurs regroupent souvent pour les minimiser : les gains perdus avant consolidation, les gains perdus après consolidation, et l'atteinte durable à votre carrière. - Remplir vous-même un tableau de recensement, pièce par pièce, pour arriver préparé au chiffrage définitif avec votre avocat.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

Pourquoi calculer vos pertes de gains

Un accident corporel ne touche pas seulement votre corps. Il touche aussi votre paie, votre chiffre d'affaires, vos missions, votre progression de carrière. Ces pertes financières constituent des postes de préjudice à part entière. La nomenclature Dintilhac, cette liste de référence des postes de préjudice corporel constamment utilisée par les juges et les experts, les identifie séparément. Elle sert d'outil de travail, non de barème.

L'objectif de ce document est simple. Vous apprenez à mesurer l'écart entre vos revenus d'avant l'accident et vos revenus d'après. Cet écart, correctement documenté, devient une créance chiffrable. Il ne suffit pas de l'affirmer. Il faut le prouver, ligne par ligne, avec vos justificatifs.

Un mot de prudence d'emblée. Ce document ne vous promet aucun montant. Il ne contient aucun barème d'indemnisation. Il vous donne une méthode et un tableau vide. Le chiffrage définitif appartient à votre avocat, qui appliquera à vos chiffres les règles d'évaluation et la jurisprudence en vigueur. Les cases du tableau sont à remplir par vous.

La notion clé : la consolidation

Avant tout calcul, un repère de temps s'impose : la consolidation. La consolidation est la date à laquelle votre état de santé se stabilise. Vous n'êtes pas forcément guéri. Simplement, votre état n'évolue plus, ni vers l'amélioration ni vers l'aggravation prévisible. C'est le médecin, souvent lors d'une expertise, qui fixe cette date.

Cette date coupe votre préjudice financier en deux périodes. Avant la consolidation, on parle de pertes de gains professionnels actuels. Après la consolidation, on parle de pertes de gains professionnels futurs. Cette frontière n'est pas une subtilité de juriste. Elle change la méthode de calcul. Retenez-la. Elle structure tout le reste de ce document et tout le tableau que vous allez remplir.

Les trois pertes à ne jamais confondre

Les assureurs ont tendance à parler d'une seule « perte de salaire ». La réalité juridique en distingue trois. Chacune se calcule autrement. Les confondre, c'est risquer d'en oublier une.

1. Les pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Il s'agit des revenus que vous n'avez pas perçus entre le jour de l'accident et la date de consolidation. C'est la période des arrêts de travail, des soins, de la rééducation. Vous avez travaillé moins, ou pas du tout. Votre revenu réel a baissé.

Le calcul repose sur une soustraction. On prend le revenu que vous auriez dû percevoir sans l'accident. On retranche le revenu réellement perçu pendant la période, ainsi que les sommes déjà versées par des tiers, par exemple les indemnités journalières de la Sécurité sociale. La différence constitue votre perte nette. Cette perte est concrète, mesurable, appuyée sur des documents datés. C'est la plus facile des trois à établir, à condition de rassembler chaque justificatif.

2. Les pertes de gains professionnels futurs (après consolidation)

Il s'agit des revenus que vous ne percevrez plus, ou plus en totalité, à partir de la consolidation et pour l'avenir. Votre état s'est stabilisé, mais avec des séquelles. Vous ne pouvez plus exercer le même métier. Vous êtes passé à temps partiel. Vous avez été déclaré inapte à votre poste. Vous êtes reclassé sur un emploi moins rémunéré.

Ce calcul est plus délicat. Il projette dans le temps une perte annuelle sur les années de vie active qui vous restent. Il fait appel à des paramètres techniques que votre avocat maîtrise. Vous n'avez pas à le mener seul. Votre rôle, à ce stade, est de documenter la perte annuelle de départ : quel revenu avant, quel revenu après consolidation. Le reste relève du chiffrage professionnel.

3. L'incidence professionnelle (l'atteinte durable à la carrière)

C'est le poste le plus souvent oublié, et le plus mal indemnisé quand la victime négocie seule. L'incidence professionnelle répare l'impact durable de l'accident sur votre vie professionnelle, au-delà de la seule perte de salaire chiffrable.

Elle recouvre plusieurs réalités concrètes. La pénibilité accrue : vous faites le même travail, mais au prix d'un effort et d'une fatigue supérieurs. La dévalorisation sur le marché du travail : à compétence égale, vos séquelles vous rendent moins « employable ». La perte de chance de promotion : la carrière que vous auriez pu construire est compromise. La perte de chance désigne la disparition d'une possibilité future qui était réelle, même si elle n'était pas certaine. On répare la chance perdue, pas la certitude d'un gain.

L'incidence professionnelle peut aussi couvrir la nécessité d'abandonner votre métier, la perte de droits à la retraite, ou une reconversion forcée. Elle ne se confond pas avec les pertes de gains futurs. Les deux se cumulent. Les pertes de gains futurs chiffrent l'argent que vous ne toucherez plus. L'incidence professionnelle indemnise l'atteinte à votre valeur et à votre avenir professionnels. Réclamer l'une sans l'autre, c'est laisser de côté une partie de votre droit.

La méthode « revenus avant, revenus après »

La logique est toujours la même. On reconstitue votre situation financière normale, celle sans l'accident. On la compare à votre situation réelle après l'accident. L'écart est le préjudice. La difficulté ne tient pas au principe. Elle

tient à la preuve, et cette preuve dépend de votre statut. Voyons les trois profils.

Profil salarié

Votre situation est la mieux documentée des trois. Vos revenus sont tracés mois après mois.

Pour établir vos revenus « avant », rassemblez vos bulletins de paie des 12 mois précédant l'accident. Ils donnent votre salaire net, mais aussi vos primes, vos heures supplémentaires régulières, votre treizième mois. Ces éléments variables comptent. Une prime annuelle perdue est une perte réelle. Ajoutez votre contrat de travail et vos deux derniers avis d'imposition.

Pour établir vos revenus « après », réunissez vos arrêts de travail, vos bulletins de paie de la période d'accident, et les décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité sociale. Notez si votre employeur a maintenu tout ou partie de votre salaire, et pour combien de temps. Notez les primes que vous n'avez pas touchées faute de présence. Si vous avez repris à temps partiel thérapeutique, conservez les justificatifs correspondants.

Profil indépendant

Votre situation demande davantage de reconstitution. Vos revenus varient d'une année sur l'autre. Ils dépendent de votre activité, donc de votre présence.

Pour établir vos revenus « avant », réunissez vos bilans comptables et vos liasses fiscales des trois derniers exercices, si possible. Une moyenne sur plusieurs années lisse les variations et donne une image fidèle. Ajoutez vos avis d'imposition et, le cas échéant, vos relevés de chiffre d'affaires. Un artisan, un commerçant, un professionnel libéral ne prouvent pas leur revenu de la même façon qu'un salarié : c'est le résultat de l'activité qui compte.

Pour établir vos revenus « après », documentez la baisse de chiffre d'affaires pendant votre incapacité. Attention à un point souvent négligé : vos charges fixes ont continué de courir, loyer professionnel, cotisations, assurances, salaires de vos éventuels employés, même à l'arrêt. Un remplaçant a peut-être été payé pour vous suppléer. Ces surcoûts font partie de votre préjudice. Conservez toutes les pièces : factures du remplaçant, relevés de charges, attestation de votre expert-comptable.

Profil intérimaire

Votre situation est la plus difficile à projeter, car votre activité est par nature discontinue. Vous enchaînez des missions, avec des périodes d'intercontrat. L'assureur peut tenter d'en profiter pour minorer votre perte. Vous devez donc être particulièrement méthodique.

Pour établir vos revenus « avant », rassemblez l'ensemble de vos contrats de mission et vos bulletins de paie sur une période longue, idéalement les 12 à 24 mois précédant l'accident. Cet historique révèle votre rythme réel de travail et votre revenu moyen. Ajoutez une attestation de votre agence d'intérim précisant votre ancienneté et la régularité de vos missions. Si une mission était programmée ou promise au moment de l'accident, gardez-en la trace écrite : elle documente une perte concrète.

Pour établir vos revenus « après », réunissez la preuve des missions que vous n'avez pas pu honorer, vos décomptes d'indemnités journalières, et tout élément montrant que votre retour à l'emploi a été retardé ou empêché par vos séquelles. La régularité passée de vos missions est votre meilleur argument pour établir ce que vous auriez raisonnablement gagné.

Un rappel utile sur vos droits

Si vous êtes victime d'un accident de la circulation et que vous n'étiez pas au volant, la loi vous protège de façon renforcée. L'article 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes non conductrices sont indemnisées des atteintes à leur personne « sans que puisse leur être opposée leur propre faute », sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident. Vos pertes de revenus entrent dans ces atteintes à indemniser.

Par ailleurs, l'assureur doit vous présenter une offre d'indemnité dans un délai encadré. L'article L211-9 du code des assurances impose une offre « dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident » pour l'atteinte à la personne. Ne signez rien sans avoir chiffré vos trois pertes. Une offre rapide n'est pas toujours une offre complète.

Trois erreurs fréquentes qui minorent votre indemnisation

La première erreur consiste à ne raisonner qu'en salaire net mensuel. Vous oubliez alors les primes, les heures supplémentaires régulières, l'intéressement, le treizième mois. Ces éléments variables font partie de votre revenu réel. Leur perte se répare comme le reste. Recensez-les.

La deuxième erreur consiste à s'arrêter à la consolidation. Beaucoup de victimes chiffrent leur arrêt de travail, acceptent une offre, et referment le dossier. Elles laissent de côté les pertes futures et l'incidence professionnelle. Or ce sont souvent les postes les plus lourds sur une vie entière. Une séquelle qui vous prive d'une promotion pèse, année après année, bien plus qu'un arrêt de quelques mois.

La troisième erreur consiste à confondre l'aide des organismes sociaux avec la réparation intégrale. Les indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente ne couvrent qu'une partie de votre perte. Elles ne l'effacent pas. Ce qui reste à votre charge après ces versements demeure un préjudice indemnisable. C'est précisément cet écart que votre tableau doit faire apparaître.

Une observation de terrain complète ce point. Les offres spontanées des assureurs sont fréquemment 2 à 5 fois inférieures à l'indemnisation réelle obtenue avec un avocat spécialisé. La raison tient rarement à la mauvaise foi. Elle tient au fait qu'une victime seule ne pense pas à réclamer tout ce à quoi elle a droit, et documente mal ce qu'elle réclame. Votre tableau est votre premier rempart contre cette sous-évaluation.

Conformément à l'article 11.1 du Règlement Intérieur National, l'avocat est tenu à une obligation de moyens, non de résultat. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Chaque situation est unique.

Votre tableau de recensement à remplir

Le tableau suivant est un outil de préparation. Remplissez chaque case à partir de vos justificatifs. Laissez vide ce que vous ne savez pas encore : votre avocat vous aidera à compléter. Ne portez aucun montant d'indemnisation dans ce tableau : vous y portez uniquement vos revenus et vos pertes constatées, pièces à l'appui.

Tableau 1. Pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation)

ÉLÉMENT	MONTANT / PÉRIODE	JUSTIFICATIF DÉTENU (OUI/NON)
Revenu net mensuel habituel avant accident		
Primes et éléments variables habituels		
Date de l'accident		
Date de consolidation (si connue)		
Durée totale d'arrêt de travail		
Revenu réellement perçu pendant l'arrêt		
Indemnités journalières Sécurité sociale reçues		
Salaire maintenu par l'employeur (le cas échéant)		
Perte nette constatée sur la période		

Tableau 2. Pertes de gains professionnels futurs (après consolidation)

ÉLÉMENT	MONTANT / PÉRIODE	JUSTIFICATIF DÉTENU (OUI/NON)
Revenu annuel avant accident		
Revenu annuel après consolidation		
Nature de la limitation (temps partiel, inaptitude, reclassement)		
Décision médicale ou d'inaptitude (référence, date)		
Perte de revenu annuelle constatée		

Tableau 3. Incidence professionnelle (atteinte durable à la carrière)

ÉLÉMENT	DESCRIPTION FACTUELLE	JUSTIFICATIF DÉTENU (OUI/NON)
Pénibilité accrue au poste		
Dévalorisation sur le marché du travail		
Perte de chance de promotion		
Reconversion ou abandon de métier imposé		
Impact sur les droits à la retraite		

Tableau 4. Justificatifs selon votre statut

STATUT	PIÈCES « AVANT » À RÉUNIR	PIÈCES « APRÈS » À RÉUNIR
Salarié	12 bulletins de paie, contrat, 2 avis d'imposition	Arrêts de travail, décomptes IJSS, attestation employeur
Indépendant	3 bilans, liasses fiscales, avis d'imposition	Relevés de charges fixes, factures remplaçant, attestation expert-comptable
Intérimaire	Contrats de mission sur 12 à 24 mois, attestation agence	Missions non honorées, décomptes IJSS, preuve du retard de reprise

Une fois le tableau rempli

Ne tirez surtout pas de ces cases un montant d'indemnisation. Un tableau de revenus n'est pas une créance chiffrée. Entre vos chiffres bruts et l'indemnité finale, il y a un travail d'évaluation juridique : application de la nomenclature, prise en compte de la consolidation, projection des pertes futures, articulation avec les organismes sociaux, discussion de l'incidence professionnelle. Ce travail revient à votre avocat. Votre tableau est la matière première. Lui en fait une demande étayée.

Votre prochaine étape Rassemblez, dès aujourd'hui, les pièces « avant » de votre statut (bulletins, bilans ou contrats de mission) dans un dossier unique : c'est la base de tout chiffrage.

Le cabinet LEXVOX AVOCATS accompagne les victimes de dommage corporel dans le chiffrage et la réclamation de leurs pertes de revenus. Me Patrice Humbert, spécialiste en réparation du dommage corporel, examine avec vous vos justificatifs et construit une demande complète, poste par poste. La première consultation, de 30 minutes, est gratuite. Vous pouvez joindre le standard au 04 90 54 58 10 ou passer par <https://lexvox-victime.com>. Le cabinet dispose de quatre bureaux en PACA, à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane.

Maître Patrice Humbert

AVOCAT AU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE · TOQUE 187 · SPÉCIALISTE CNB EN DOMMAGE CORPOREL
 MASTER EN DROIT DE LA SANTÉ · FORMATION MÉDICALE EN TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL
 SELARL LEXVOX AVOCATS · 4 BUREAUX EN PACA · 04 90 54 58 10 · LEXVOX-VICTIME.COM

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15.